QCM de révision

60 questions · Corrigés regroupés à la fin

Comprendre les déterminants de santé

Q01 **Quelles propositions décrivent un déterminant de santé ? (2 bonnes réponses)** — Facile

- ☐ A. Il peut agir à l'échelle d'une population.
- ☐ B. Il peut constituer une ressource favorable à la santé.
- ☐ C. Il désigne une conséquence déjà observée d'une maladie.
- ☐ D. Il correspond à un diagnostic posé par un médecin.
- ☐ E. Il désigne uniquement les habitudes choisies par la personne.

Q02 **À propos des facteurs de risque et des déterminants : (2 bonnes réponses)** — Moyen

- ☐ A. Un facteur de risque rend la maladie certaine chez chaque personne exposée.
- ☐ B. Le contexte professionnel peut aider à expliquer une exposition.
- ☐ C. Le tabagisme peut être étudié comme facteur de risque.
- ☐ D. Déterminant et facteur de risque s'excluent toujours.
- ☐ E. Le revenu est une mesure de gravité d'une maladie.

Q03 **Une personne suit difficilement son traitement. Quels raisonnements sont pertinents ? (3 bonnes réponses)** — Difficile

- ☐ A. S'intéresser à l'organisation quotidienne.
- ☐ B. Explorer les obstacles financiers.
- ☐ C. Déduire un refus à partir de la seule irrégularité des prises.
- ☐ D. Répéter la même consigne avant de rechercher les obstacles.
- ☐ E. Vérifier la compréhension du traitement.

Q04 **Quels champs appartiennent au cadre proposé par le rapport de Lalonde ? (3 bonnes réponses)** — Facile

- ☐ A. Les habitudes de vie et l'organisation des soins.
- ☐ B. Les trois phases d'une maladie aiguë.
- ☐ C. Les cinq formes de non-recours.
- ☐ D. L'environnement.
- ☐ E. La biologie humaine.

Les grands risques : comprendre leurs interactions

Q05 — **Concernant les conséquences du tabagisme : (2 bonnes réponses)** — Facile

- [ ] A. Le tabac ne joue un rôle que si une autre exposition est présente.
- [ ] B. Les atteintes peuvent être cardiovasculaires.
- [ ] C. Les atteintes peuvent être respiratoires.
- [ ] D. Étudier le tabac dispense d'étudier sa répartition sociale.
- [ ] E. La présence d'une exposition établit à elle seule un diagnostic.

Q06 — **À propos de l'alcool et des repères de réduction des risques : (1 bonne réponse)** — Moyen

- [ ] A. Le repère permet de prédire le devenir de chaque personne.
- [ ] B. Les conséquences de l'alcool se limitent aux accidents.
- [ ] C. Un repère de consommation est un critère diagnostique suffisant.
- [ ] D. Réduire la consommation ne signifie pas supprimer tout risque.
- [ ] E. Une consommation située sous un repère devient protectrice contre les cancers.

Q07 — **Quelles conséquences peuvent participer aux risques liés à l'alcool ? (3 bonnes réponses)** — Facile

- [ ] A. Des atteintes du foie et du système nerveux.
- [ ] B. Des cancers.
- [ ] C. Uniquement une modification du poids.
- [ ] D. Des accidents et des chutes.
- [ ] E. Une protection générale du système cardiovasculaire.

Q08 — **Comment interpréter l'association de plusieurs expositions ? (1 bonne réponse)** — Difficile

- [ ] A. Plusieurs expositions peuvent renforcer leurs effets.
- [ ] B. L'exposition la plus visible rend les autres sans importance.
- [ ] C. Deux risques relatifs se somment nécessairement.
- [ ] D. La combinaison permet un diagnostic individuel certain.
- [ ] E. Une association statistique supprime le besoin de préciser la population.

Alimentation, activité et gradient des expositions

Q09 — Moyen

À propos de la sédentarité : (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Le temps assis hors sommeil est pertinent.
- [ ] B. Une séance de sport ne décrit pas toute la journée.
- [ ] C. Sédentarité et absence de sport sont strictement synonymes.
- [ ] D. La sédentarité est une protection cardiovasculaire.
- [ ] E. Le sommeil constitue la définition de la sédentarité.

Q10 — Difficile

Une enquête de 2020 rapporte 47,3 % d'adultes en excès de poids, dont 17 % en situation d'obésité. Comment lire ces valeurs ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Le chiffre de 17 % décrit nécessairement toutes les populations actuelles.
- [ ] B. Le total des personnes concernées est de 64,3 %.
- [ ] C. Les deux proportions décrivent deux groupes forcément disjoints.
- [ ] D. L'obésité est incluse dans l'excès de poids annoncé.
- [ ] E. L'année et la population de l'enquête doivent être conservées.

Q11 — Moyen

Concernant le gradient social des expositions : (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Les groupes les moins favorisés sont les plus exposés à tout risque mesurable.
- [ ] B. Une catégorie sociale permet de prédire la consommation de chaque membre.
- [ ] C. La répartition doit être examinée pour chaque exposition.
- [ ] D. Le choix de l'indicateur compte.
- [ ] E. Une association avec le chômage prouve un comportement volontaire identique chez tous.

Q12 — Moyen

Une personne reçoit des conseils alimentaires mais ne dispose pas d'équipement pour cuisiner. Quelles démarches sont pertinentes ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Écarter le logement du raisonnement nutritionnel.
- [ ] B. Conclure que l'absence de changement prouve un désintérêt.
- [ ] C. Limiter l'échange à une nouvelle liste d'aliments recommandés.
- [ ] D. Rechercher les possibilités concrètes de préparation ou d'accès aux repas.
- [ ] E. Explorer le budget et les ressources locales avec la personne.

Dahlgren–Whitehead : cinq couches imbriquées

Q13 — Facile

Quels éléments se situent au centre du modèle de Dahlgren et Whitehead ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. L'organisation du marché du travail.
- [ ] B. Les réseaux de voisinage.
- [ ] C. La constitution et l'hérédité.
- [ ] D. L'âge et le sexe biologique.
- [ ] E. La publicité alimentaire.

Q14 — Facile

Quelle classification respecte le modèle de Dahlgren et Whitehead ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. L'accès aux services est une caractéristique biologique innée.
- [ ] B. Le soutien des proches relève des réseaux sociaux et communautaires.
- [ ] C. Le tabagisme définit à lui seul les politiques économiques générales.
- [ ] D. Le logement relève exclusivement du patrimoine génétique.
- [ ] E. L'hérédité relève des conditions de travail.

Q15 — Moyen

Comment comprendre les cinq couches du modèle ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Des horaires de travail peuvent influencer le sommeil.
- [ ] B. L'état de santé s'obtient en additionnant cinq coefficients fixes.
- [ ] C. Un facteur ne peut jamais avoir de lien avec plusieurs couches.
- [ ] D. Les couches extérieures n'ont pas d'effet sur les comportements.
- [ ] E. Une politique peut modifier les possibilités d'accès à des services.

Q16 — Moyen

Que signifie le caractère modifiable d'une habitude de vie ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Des contraintes sociales peuvent limiter le changement.
- [ ] B. Le changement dépend uniquement d'une décision instantanée.
- [ ] C. Une habitude contrainte doit être reclassée comme héréditaire.
- [ ] D. Un conseil identique suffit dans toutes les situations.
- [ ] E. Une aide peut agir sur l'environnement de la personne.

Du contexte quotidien aux déterminants structuraux

Q17 **À propos du capital social : (2 bonnes réponses)** Facile

- ☐ A. Il désigne le montant du revenu disponible.
- ☐ B. Il peut faciliter l'organisation d'un déplacement vers les soins.
- ☐ C. Il correspond à l'ensemble des équipements hospitaliers.
- ☐ D. La présence d'un entourage garantit toujours un effet protecteur.
- ☐ E. Il peut faciliter la compréhension d'une information.

Q18 **Quels liens peuvent unir travail et santé ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. L'emploi influence les ressources matérielles.
- ☐ B. Les horaires peuvent rendre certains rendez-vous difficiles.
- ☐ C. L'emploi ne concerne que le mode de vie biologique inné.
- ☐ D. La pénibilité et les expositions peuvent affecter la santé.
- ☐ E. Un emploi protège nécessairement de tout problème de santé.

Q19 **Une personne privilégie une urgence de logement avant un rendez-vous. Comment analyser cette situation ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Assimiler cette priorité à une incapacité définitive de décider.
- ☐ B. Explorer la stabilité et les contraintes du logement.
- ☐ C. Discuter des priorités avec la personne.
- ☐ D. Renouveler uniquement l'horaire sans explorer l'obstacle.
- ☐ E. Considérer le logement comme extérieur à la santé.

Q20 **Quels exemples relèvent de déterminants structuraux ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. La seule fréquence cardiaque d'une personne au repos.
- ☐ B. Les politiques sociales et économiques.
- ☐ C. Les discriminations et la stigmatisation.
- ☐ D. La constitution héréditaire comme unique explication du contexte social.
- ☐ E. La protection sociale et la fiscalité.

Les déterminants commerciaux

Q21 **Quels mécanismes participent aux déterminants commerciaux de santé ? (3 bonnes réponses)** — Facile

- ☐ A. L'influence sur les décisions publiques.
- ☐ B. La promotion de produits.
- ☐ C. Uniquement le choix final de l'acheteur.
- ☐ D. Les conditions de production et leurs effets environnementaux.
- ☐ E. Toute variation biologique liée à l'âge.

Q22 **À quoi correspond le lobbying dans l'analyse des déterminants commerciaux ? (2 bonnes réponses)** — Moyen

- ☐ A. Désigner une caractéristique héréditaire.
- ☐ B. Peser sur des décisions relatives aux prix.
- ☐ C. Peser sur des règles de publicité ou d'information.
- ☐ D. Mesurer directement le nombre de nouveaux cas d'une maladie.
- ☐ E. Remplacer nécessairement toute forme de décision publique.

Q23 **Comment utiliser un indicateur d'aide au choix alimentaire tel que le Nutri-Score ? (2 bonnes réponses)** — Moyen

- ☐ A. En déduire que tous les ménages ont les mêmes possibilités de choix.
- ☐ B. Distinguer aide à la comparaison et description exhaustive.
- ☐ C. Le traiter comme une information couvrant toutes les dimensions d'un aliment.
- ☐ D. Supprimer l'analyse de l'environnement commercial.
- ☐ E. Tenir compte des contraintes financières.

Q24 **Présenter la santé comme le seul résultat de décisions personnelles peut avoir quels effets ? (2 bonnes réponses)** — Difficile

- ☐ A. Rendre inutile toute aide à la personne.
- ☐ B. Démontrer que les conditions économiques n'interviennent pas.
- ☐ C. Masquer certains obstacles matériels.
- ☐ D. Établir que les personnes n'ont aucune capacité d'action.
- ☐ E. Faire oublier l'influence de la promotion commerciale.

Inégalités de santé et gradient social

Q25 — **À propos des inégalités sociales de santé : (2 bonnes réponses)** — Moyen

- [ ] A. Elles disparaissent dès qu'une moyenne nationale s'améliore.
- [ ] B. Elles peuvent concerner la répartition des expositions.
- [ ] C. Elles correspondent uniquement à des variations génétiques.
- [ ] D. Elles peuvent concerner l'accès aux ressources et aux soins.
- [ ] E. Toute différence entre deux personnes est nécessairement une inégalité sociale.

Q26 — **Que décrit le gradient social de santé ? (1 bonne réponse)** — Facile

- [ ] A. Une différence présente uniquement entre les deux catégories extrêmes.
- [ ] B. La preuve que le revenu est la seule explication possible.
- [ ] C. Une évolution de la santé selon la position sociale.
- [ ] D. Un diagnostic identique chez tous les membres d'un groupe.
- [ ] E. Une échelle de gravité propre à une seule maladie.

Q27 — **En 2020–2022, un graphique compare chez des hommes de 35 ans 40,5 et 48,5 années restantes selon le diplôme. Quelles lectures sont correctes ? (2 bonnes réponses)** — Difficile

- [ ] A. Les valeurs expriment des années restant à vivre à 35 ans.
- [ ] B. Chaque homme du groupe vivra exactement cette durée.
- [ ] C. L'axe du diplôme peut être renommé catégorie professionnelle sans précaution.
- [ ] D. Le groupe à 40,5 années meurt en moyenne à 40,5 ans.
- [ ] E. L'écart entre les deux valeurs est de 8 ans.

Q28 — **Un graphique rapproche PIB par habitant et espérance de vie à la naissance. Que permet-il d'affirmer ? (1 bonne réponse)** — Difficile

- [ ] A. Les deux indicateurs peuvent être associés à l'échelle des pays.
- [ ] B. Aucune autre condition collective ne peut contribuer aux écarts.
- [ ] C. Doubler le PIB double nécessairement l'espérance de vie.
- [ ] D. L'association identifie à elle seule le mécanisme causal.
- [ ] E. Le graphique donne la durée de vie certaine d'un habitant.

Genre, discriminations et adéquation des soins

Q29 — Facile

Comment distinguer sexe biologique et genre dans l'analyse de la santé ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Le genre ne peut agir que par la génétique.
- [ ] B. Genre et sexe biologique sont deux termes strictement interchangeables.
- [ ] C. Le sexe biologique figure au centre du modèle de Dahlgren et Whitehead.
- [ ] D. Le genre peut influencer les rôles et les charges attendus.
- [ ] E. Toute plainte peut être interprétée à partir du sexe seul.

Q30 — Difficile

Une plainte thoracique est rapidement attribuée à l'angoisse sur la base d'un stéréotype de genre. Que met cette situation en évidence ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. La situation permet d'exclure la plainte sans examen.
- [ ] B. Une consultation réalisée ne garantit pas l'adéquation de la réponse.
- [ ] C. Les représentations peuvent influencer l'interprétation d'une plainte.
- [ ] D. Le stéréotype constitue un critère diagnostique suffisant.
- [ ] E. Le biais se situe uniquement avant le premier contact avec les soins.

Q31 — Moyen

Quels mécanismes peuvent relier discrimination et recours aux soins ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. La crainte d'un jugement peut décourager une demande.
- [ ] B. Une expérience de stigmatisation peut réduire la confiance.
- [ ] C. Une offre connue est toujours utilisée sans hésitation.
- [ ] D. Un rendez-vous disponible efface nécessairement une discrimination.
- [ ] E. Le refus apparent prouve systématiquement un désintérêt pour la santé.

Q32 — Moyen

Quelles propositions décrivent l'adéquation des soins ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. La réponse doit correspondre au besoin réel.
- [ ] B. Elle se mesure uniquement par le nombre de bâtiments de soins.
- [ ] C. L'organisation des services peut être en jeu.
- [ ] D. Les compétences professionnelles peuvent être en jeu.
- [ ] E. Elle suppose d'appliquer le même raisonnement à toutes les personnes sans évaluation.

Besoin, accès, recours et poursuite des soins

Q33 — Facile

Quel enchaînement décrit trois grandes étapes du parcours de soins ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Recours, disparition obligatoire du besoin, guérison certaine.
- [ ] B. Publication d'une offre, consultation, absence définitive d'obstacles.
- [ ] C. Connaissance d'un service et utilisation sont la même étape.
- [ ] D. Diagnostic, hérédité, fiscalité.
- [ ] E. Besoin perçu, recours, utilisation et poursuite.

Q34 — Moyen

À propos de l'accès et du recours aux soins : (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Un service présent signifie que chaque personne le consulte.
- [ ] B. Un contact réalisé ne garantit pas la poursuite des soins.
- [ ] C. Une possibilité d'accès ne garantit pas le recours.
- [ ] D. Le recours résume la durée du traitement.
- [ ] E. Accès et recours sont deux noms d'une même mesure obligatoire.

Q35 — Moyen

Une personne comprend son besoin mais ne peut pas se déplacer vers le service. Quels éléments analyser ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. La proximité et la répartition de l'offre.
- [ ] B. Les possibilités de déplacement de la personne.
- [ ] C. La poursuite du traitement comme unique étape concernée.
- [ ] D. Une preuve que la personne refuse les soins.
- [ ] E. Uniquement sa capacité à reconnaître un symptôme.

Q36 — Difficile

Après une consultation, une personne ne peut pas poursuivre les soins en raison du coût et de ses horaires. Quelles interprétations sont pertinentes ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Attribuer d'emblée la difficulté à une opposition volontaire.
- [ ] B. Examiner l'adaptation de l'organisation et du projet.
- [ ] C. Considérer que tous les obstacles sont résolus puisque la consultation a eu lieu.
- [ ] D. Rechercher les contraintes de l'utilisation durable.
- [ ] E. Classer systématiquement la situation comme non-connaissance de l'offre.

La littératie en santé

Q37 Facile

Quelles opérations appartiennent à la littératie en santé ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Comprendre et évaluer l'information.
- [ ] B. Utiliser l'information pour agir.
- [ ] C. Mémoriser toute information sans la discuter.
- [ ] D. Accéder à une information utile.
- [ ] E. Posséder un diplôme suffit nécessairement.

Q38 Moyen

Comment s'articulent les approches clinique et de santé publique de la littératie ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. La littératie relève uniquement de compétences individuelles immuables.
- [ ] B. L'approche clinique peut concerner la compréhension d'un traitement.
- [ ] C. Choisir l'une interdit d'utiliser l'autre.
- [ ] D. L'approche de santé publique élargit la réflexion à la prévention et à la vie quotidienne.
- [ ] E. L'approche de santé publique exclut toute compréhension de l'information.

Q39 Moyen

Une prise de rendez-vous exclusivement numérique met une personne en difficulté. Que rechercher ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. La compréhension du parcours proposé.
- [ ] B. La maîtrise de l'outil numérique.
- [ ] C. Un désintérêt certain pour la santé.
- [ ] D. La disponibilité de l'équipement.
- [ ] E. L'absence de tout obstacle lié à l'organisation de l'offre.

Q40 Moyen

Pour vérifier la compréhension d'une démarche de santé, quelles pratiques sont cohérentes ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Assimiler une bonne répétition des mots à une mise en pratique certaine.
- [ ] B. Déduire la compréhension du seul niveau de diplôme.
- [ ] C. Adapter les mots utilisés.
- [ ] D. Multiplier les termes techniques sans explication.
- [ ] E. Vérifier ce que la personne a compris.

Le non-recours : trois formes à distinguer

Q41 — Facile

Que désigne le non-recours à une offre ou à un droit ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Uniquement le refus explicite d'un soin proposé.
- [ ] B. La preuve que le dispositif n'existe pas.
- [ ] C. Une absence de bénéfice effectif malgré une possibilité d'y prétendre.
- [ ] D. Un diagnostic de manque de motivation.
- [ ] E. Toute absence de maladie dans une population.

Q42 — Facile

Une personne ignore qu'un service pourrait la concerner. Quelle forme de non-recours est décrite ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. La non-réception après une demande complète.
- [ ] B. La non-connaissance.
- [ ] C. Une adhésion durable au projet.
- [ ] D. Une impossibilité biologique d'accéder à toute information.
- [ ] E. La poursuite effective des soins.

Q43 — Moyen

Une personne connaît une aide mais renonce à déposer sa demande par crainte d'être jugée. Quelle analyse retenir ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. La prestation a nécessairement été reçue.
- [ ] B. Il s'agit nécessairement de non-connaissance.
- [ ] C. L'offre connue est toujours demandée.
- [ ] D. Une non-demande est possible.
- [ ] E. La crainte du jugement peut participer au mécanisme.

Q44 — Moyen

Une demande est engagée mais la prestation n'arrive pas en raison d'un obstacle administratif. Quelle forme de non-recours est illustrée ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. La non-réception.
- [ ] B. La preuve que le droit est identique dans tous les dispositifs.
- [ ] C. L'utilisation durable du service.
- [ ] D. La preuve que la personne n'a jamais voulu demander.
- [ ] E. La seule non-connaissance de l'offre.

Intervenir : universel ne signifie pas uniforme

Q45 **Quels niveaux peut viser une intervention de santé publique ? (3 bonnes réponses)** Facile

- [ ] A. Le niveau systémique.
- [ ] B. Exclusivement le niveau biologique inné.
- [ ] C. Le niveau individuel ou familial.
- [ ] D. Le niveau communautaire.
- [ ] E. Exclusivement une consultation médicale.

Q46 **Que caractérise l'universalisme proportionné ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Une portée universelle.
- [ ] B. Un soutien plus important lorsque les besoins sont plus importants.
- [ ] C. La seule amélioration d'une moyenne sans examiner les écarts.
- [ ] D. Une action réservée uniquement à un groupe excluant les autres.
- [ ] E. Des moyens strictement identiques pour tous, quelles que soient les difficultés.

Q47 **Une campagne identique pour tous bénéficie surtout aux personnes disposant déjà de nombreuses ressources. Que peut-il se passer ? (2 bonnes réponses)** Difficile

- [ ] A. Les inégalités mesurées prouvent que toute prévention est inutile.
- [ ] B. Il suffit de supprimer toute offre universelle.
- [ ] C. La moyenne peut s'améliorer alors que les écarts persistent.
- [ ] D. Un accompagnement adapté peut être nécessaire.
- [ ] E. Une offre identique garantit nécessairement des bénéfices identiques.

Q48 **Quelle situation illustre un universalisme proportionné ? (1 bonne réponse)** Moyen

- [ ] A. La suppression de l'aide dès que la moyenne progresse.
- [ ] B. Une aide graduée attribuée sans évaluer les difficultés.
- [ ] C. Une information réservée aux personnes déjà équipées numériquement.
- [ ] D. Une information pour tous, avec une aide supplémentaire selon les obstacles.
- [ ] E. Le même accompagnement obligatoire, indépendamment des besoins.

La roue des interventions et l'exemple HPV

Q49 **Comment comprendre la roue des interventions de santé publique ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Elle correspond aux cinq couches de Dahlgren et Whitehead sans autre distinction.
- ☐ B. Elle comprend cinq niveaux biologiques de gravité.
- ☐ C. Elle décrit une diversité de moyens d'action.
- ☐ D. Chaque action doit utiliser exactement les dix-sept fonctions.
- ☐ E. Plusieurs fonctions peuvent participer à une même intervention.

Q50 **Quelles associations fonction–action sont cohérentes ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Coordonner plusieurs intervenants se réduit à une publicité commerciale.
- ☐ B. Mesurer un indicateur constitue à lui seul une gestion de cas.
- ☐ C. Mettre une personne en relation avec un service relève de l'orientation.
- ☐ D. Solliciter une expertise signifie exclusivement prendre un rendez-vous de soins.
- ☐ E. Suivre une couverture vaccinale relève de la surveillance.

Q51 **Quelles propositions décrivent l'aller-vers ? (2 bonnes réponses)** Facile

- ☐ A. Une équipe intervient dans un établissement scolaire ou une communauté.
- ☐ B. L'aller-vers supprime tout besoin de coopération locale.
- ☐ C. La démarche inverse une logique d'attente dans les services.
- ☐ D. Le public doit obligatoirement se déplacer à l'hôpital.
- ☐ E. L'aller-vers garantit à lui seul l'absence de tout obstacle ultérieur.

Q52 **À propos du plaidoyer et du marketing social : (2 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Le marketing social peut adapter une communication à un public.
- ☐ B. Le marketing social vise nécessairement à vendre un produit.
- ☐ C. Le plaidoyer peut faire prendre en compte un enjeu dans une politique.
- ☐ D. Le plaidoyer désigne uniquement un test de dépistage.
- ☐ E. Une campagne HPV ne peut mobiliser qu'une seule fonction.

Des stratégies publiques aux différentes couches

Q53 Moyen

À quoi sert l'étude de stratégies publiques dans une analyse des déterminants ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Confondre domaine de stratégie et calendrier clinique individuel.
- [ ] B. Repérer les différents niveaux mobilisés.
- [ ] C. Classer toute politique dans le patrimoine génétique.
- [ ] D. Relier une orientation à des conditions de vie et à des ressources.
- [ ] E. Déduire qu'un titre de stratégie garantit tous ses résultats.

Q54 Moyen

Quels liens illustrent les politiques d'alimentation, de nutrition et de climat ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. L'alimentation dépend uniquement de caractéristiques innées.
- [ ] B. Le prix et l'accessibilité de l'offre influencent les possibilités de choix.
- [ ] C. Une stratégie alimentaire supprime toute contrainte de budget dès sa publication.
- [ ] D. Des projets territoriaux peuvent mobiliser des ressources locales.
- [ ] E. Les pratiques alimentaires peuvent être liées à l'environnement.

Q55 Difficile

Quelles classifications évitent une lecture trop rigide des déterminants ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Une politique ciblée selon l'âge devient elle-même une caractéristique innée.
- [ ] B. Une action peut mobiliser plusieurs couches du modèle.
- [ ] C. Les couches du modèle interdisent tout chevauchement d'action.
- [ ] D. Toute particularité territoriale relève forcément de la génétique.
- [ ] E. Un territoire peut être étudié par ses conditions culturelles et environnementales.

Q56 Moyen

Que peut mobiliser un projet alimentaire territorial ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Une coopération entre acteurs locaux.
- [ ] B. Une réflexion sur l'accessibilité de l'alimentation.
- [ ] C. Une modification directe de l'hérédité des habitants.
- [ ] D. Une intervention sans lien avec les conditions de vie.
- [ ] E. Une garantie de résultat identique chez chaque personne.

Mobiliser le raisonnement infirmier

Q57 Difficile

Une personne diabétique a des horaires contraints, un logement instable et peu de soutien. Quelles démarches complètent le raisonnement clinique ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Déduire l'absence d'effort à partir de l'irrégularité du suivi.
- ☐ B. Vérifier la compréhension du projet.
- ☐ C. Remplacer toute évaluation clinique par une étiquette sociale.
- ☐ D. Explorer les possibilités concrètes de suivre le projet.
- ☐ E. Identifier les ressources disponibles avec la personne.

Q58 Moyen

Que signifie « décrire sans juger » dans une démarche infirmière ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Remplacer les observations par une catégorie sociale.
- ☐ B. Distinguer le comportement observé d'une intention supposée.
- ☐ C. Écouter la demande et les priorités de la personne.
- ☐ D. Considérer toute difficulté comme un défaut personnel.
- ☐ E. Renoncer à rechercher les besoins réels.

Q59 Moyen

Après la mise en place d'une aide, que faut-il réévaluer ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. La possibilité concrète d'utiliser l'aide.
- ☐ B. Uniquement l'existence d'une brochure remise.
- ☐ C. Le seul nombre de conseils formulés.
- ☐ D. L'absence de besoin d'échange ultérieur.
- ☐ E. La présence d'autres obstacles après le premier contact.

Q60 Moyen

Quelle posture respecte une analyse individualisée des déterminants ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Utiliser les déterminants pour orienter des questions.
- ☐ B. Déduire à l'avance tous les besoins d'un groupe.
- ☐ C. Opposer systématiquement clinique et contexte social.
- ☐ D. Attribuer la même difficulté à toutes les personnes précaires.
- ☐ E. Vérifier la situation propre à la personne.

Corrigés argumentés

Comprendre les déterminants de santé

Q01 — Réponses : A, B. Un facteur personnel, social, économique ou environnemental qui influence la santé d'une personne ou d'une population. Son influence peut être favorable ou défavorable. A : Vrai. Les déterminants concernent aussi la répartition collective de la santé. B : Vrai. Un déterminant n'est pas nécessairement un risque. C : Faux. Il s'agit d'un facteur d'influence, à distinguer de la conséquence. D : Faux. Le diagnostic décrit un problème ; le déterminant aide à expliquer son contexte. E : Faux. Les conditions économiques et environnementales en font également partie.

Q02 — Réponses : B, C. Un facteur de risque est associé à une probabilité accrue de problème ; l'analyse des déterminants examine aussi les conditions de cette exposition. Ces deux lectures se complètent. A : Faux. Une probabilité accrue n'est pas une certitude individuelle. B : Vrai. Les conditions de travail peuvent façonner les habitudes et les ressources. C : Vrai. Il renvoie à une exposition associée à des problèmes de santé. D : Faux. Une exposition peut être étudiée à ces deux niveaux. E : Faux. Il constitue une ressource socio-économique, non un score de gravité.

Q03 — Réponses : A, B, E. Le coût, la compréhension, les horaires, le logement et les ressources de soutien disponibles. Ces contraintes peuvent limiter la possibilité de suivre le traitement. A : Vrai. Les horaires et la charge familiale peuvent limiter la mise en pratique. B : Vrai. Le coût peut empêcher la réalisation du projet de soins. C : Faux. Le comportement observé ne suffit pas à identifier sa cause. D : Faux. Un conseil inchangé peut rester impraticable si la contrainte persiste. E : Vrai. Comprendre les consignes participe à leur utilisation.

Q04 — Réponses : A, D, E. Biologie humaine, environnement, habitudes de vie et organisation des soins. Ce cadre élargit l'explication de la santé au-delà des soins. A : Vrai. Ces deux domaines complètent les champs biologique et environnemental. B : Faux. Il s'agit de champs d'influence sur la santé, non d'une chronologie clinique. C : Faux. Le non-recours ne définit pas les quatre champs de ce cadre. D : Vrai. Ce champ dépasse les caractéristiques biologiques individuelles. E : Vrai. C'est l'un des quatre champs du cadre de Lalonde.

Les grands risques : comprendre leurs interactions

Q05 — Réponses : B, C. Le tabac contribue aussi à des maladies cardiovasculaires et à des atteintes respiratoires. Une même exposition peut avoir plusieurs conséquences. A : Faux. Son rôle ne dépend pas obligatoirement d'une association avec un autre produit. B : Vrai. Les effets du tabac ne sont pas limités aux cancers. C : Vrai. Le système respiratoire fait partie des systèmes concernés. D : Faux. Comprendre qui est exposé fait partie de l'analyse des déterminants. E : Faux. Une exposition ne remplace pas l'évaluation clinique.

Corrigés argumentés

Q06 — Réponses : D. Limiter une exposition peut réduire certains risques sans les supprimer. Un repère ne garantit donc pas une protection contre les cancers. A : Faux. Une référence populationnelle ne donne pas un pronostic individuel certain. B : Faux. Des atteintes chroniques et d'autres systèmes sont également concernés. C : Faux. Le diagnostic ne se déduit pas de ce seul repère. D : Vrai. Réduction du risque et risque nul sont distincts. E : Faux. Un repère de réduction n'établit pas un effet protecteur.

Q07 — Réponses : A, B, D. Des atteintes de plusieurs organes, des cancers, ainsi que des accidents et des chutes. La prévention doit considérer les effets aigus et chroniques. A : Vrai. Les conséquences concernent plusieurs organes et fonctions. B : Vrai. La cancérogénicité ne doit pas être effacée par les seuls risques d'accident. C : Faux. Les effets dépassent très largement cette seule dimension. D : Vrai. Les risques incluent des événements aigus. E : Faux. Cette formulation transforme à tort l'exposition en protection universelle.

Q08 — Réponses : A. Les expositions peuvent interagir ; une règle d'addition ne peut pas être supposée. Il faut distinguer combinaison d'expositions et calcul d'un effet. A : Vrai. Une interaction entre expositions doit être envisagée. B : Faux. Des expositions concomitantes peuvent contribuer au problème. C : Faux. Aucune règle universelle d'addition ne découle de leur association. D : Faux. Un risque ne suffit pas à établir la maladie d'une personne. E : Faux. Le contexte de mesure reste nécessaire.

Alimentation, activité et gradient des expositions

Q09 — Réponses : A, B. La sédentarité concerne aussi le temps passé assis ou allongé hors sommeil dans des activités peu dépensières. Il faut donc examiner l'ensemble de la journée. A : Vrai. La sédentarité concerne les comportements peu dépensiers au quotidien. B : Vrai. Le reste du temps peut rester très sédentaire. C : Faux. Ces deux descriptions ne recouvrent pas exactement les mêmes comportements. D : Faux. Elle est abordée parmi les expositions défavorables. E : Faux. Le temps de sommeil est distingué dans cette notion.

Q10 — Réponses : D, E. Les personnes en situation d'obésité sont incluses dans les 47,3 pour cent en excès de poids. Additionner les deux compterait une partie des personnes deux fois. A : Faux. Une enquête datée ne permet pas cette généralisation. B : Faux. Cette addition compte deux fois le sous-groupe en situation d'obésité. C : Faux. Le sous-groupe obésité appartient à l'ensemble excès de poids. D : Vrai. Le mot « dont » indique une inclusion dans le groupe total. E : Vrai. Ce sont des données situées, non une mesure intemporelle.

Corrigés argumentés

Q11 — Réponses : C, D. Non. Le sens et l'ampleur du gradient dépendent de l'exposition et de l'indicateur étudiés. Certains indicateurs d'alcool suivent une répartition différente de celle du tabac. A : Faux. Cette généralisation ne respecte pas la diversité des expositions. B : Faux. Une tendance de groupe n'est pas une prédiction individuelle. C : Vrai. Le gradient n'est pas identique pour tous les comportements. D : Vrai. Des indicateurs différents peuvent décrire des aspects différents d'une consommation. E : Faux. L'association ne fournit ni cette causalité ni cette uniformité.

Q12 — Réponses : D, E. Une réponse à la contrainte matérielle et la recherche de solutions réellement accessibles. L'information ne crée pas à elle seule l'équipement nécessaire. A : Faux. Le logement peut conditionner la préparation et la conservation des repas. B : Faux. Le comportement peut être empêché par les conditions de vie. C : Faux. Cette liste ne résout pas l'impossibilité matérielle identifiée. D : Vrai. La solution doit tenir compte de la contrainte matérielle. E : Vrai. Ces ressources conditionnent les possibilités d'action.

Dahlgren–Whitehead : cinq couches imbriquées

Q13 — Réponses : C, D. L'âge, le sexe biologique, la constitution et l'hérédité. Ils se distinguent des habitudes et des conditions collectives. A : Faux. Elle relève du contexte collectif et des conditions de vie. B : Faux. Ils appartiennent aux réseaux sociaux et communautaires. C : Vrai. Elles appartiennent également au centre biologique du modèle. D : Vrai. Ce sont des caractéristiques individuelles centrales du modèle. E : Faux. Elle renvoie notamment aux déterminants commerciaux.

Q14 — Réponses : B. Aux réseaux sociaux et communautaires. Cette couche décrit des liens et des ressources relationnelles. A : Faux. Il dépend des conditions de vie et de l'organisation collective. B : Vrai. Il représente une ressource relationnelle. C : Faux. Il est classé parmi les modes de vie, influencés par d'autres niveaux. D : Faux. Il fait partie des conditions matérielles de vie. E : Faux. Elle se situe au centre biologique du modèle.

Q15 — Réponses : A, E. Les niveaux sont imbriqués et s'influencent : les conditions collectives façonnent les ressources et les habitudes. Le classement sert à expliquer des liens, pas à additionner des causes isolées. A : Vrai. Les conditions de travail peuvent agir sur le mode de vie. B : Faux. Le modèle n'est pas cette formule de calcul. C : Faux. Une même situation peut articuler plusieurs niveaux. D : Faux. Le modèle souligne au contraire leur influence. E : Vrai. Une couche collective peut agir sur les conditions quotidiennes.

Corrigés argumentés

Q16 — Réponses : A, E. Une habitude peut être modifiée tout en restant contrainte par le budget, le travail, le logement ou l'entourage. La possibilité de changement dépend aussi du contexte. A : Vrai. Modifiable n'implique pas l'absence d'obstacles. B : Faux. Les conditions de mise en pratique doivent être considérées. C : Faux. Une contrainte sociale ne transforme pas un comportement en caractère génétique. D : Faux. Les besoins et les obstacles peuvent différer. E : Vrai. Faciliter les conditions peut rendre le changement possible.

Du contexte quotidien aux déterminants structuraux

Q17 — Réponses : B, E. Les ressources relationnelles accessibles à travers les proches, les groupes et les réseaux d'entraide. Ces liens peuvent soutenir la compréhension, l'organisation ou une démarche. A : Faux. Le revenu est une ressource économique, distincte du capital relationnel. B : Vrai. Un réseau peut apporter une aide pratique. C : Faux. Ces équipements relèvent de l'offre de soins. D : Faux. Les effets des liens dépendent de leur nature et du contexte. E : Vrai. L'entourage peut constituer une ressource informationnelle.

Q18 — Réponses : A, B, D. Par les expositions, la pénibilité, les horaires, le stress, la fatigue et les ressources matérielles. Le travail peut aussi modifier les possibilités de prévention et de soins. A : Vrai. Les ressources conditionnent certaines possibilités d'action. B : Vrai. L'organisation du travail peut constituer un obstacle temporel. C : Faux. Il relève de conditions sociales et matérielles. D : Vrai. Les conditions de travail peuvent créer des risques. E : Faux. Le type et les conditions du travail comptent.

Q19 — Réponses : B, C. Des besoins matériels immédiats peuvent rendre la démarche difficile à organiser ou moins prioritaire pour la personne. Cela ne prouve pas une absence d'intérêt pour sa santé. A : Faux. Une contrainte n'abolit pas la capacité de participation de la personne. B : Vrai. Elles peuvent limiter les possibilités d'organisation des soins. C : Vrai. Une aide réaliste doit tenir compte de sa situation. D : Faux. Le même obstacle matériel risque de persister. E : Faux. Le logement est un déterminant des conditions de vie.

Q20 — Réponses : B, C, E. Les politiques, les règles collectives et le contexte économique qui répartissent les ressources et les conditions de vie. Ils agissent en amont de nombreuses situations individuelles. A : Faux. C'est une mesure individuelle, non une règle structurale. B : Vrai. Elles façonnent la répartition des ressources et des possibilités. C : Vrai. Elles peuvent organiser des différences d'accès aux ressources et aux soins. D : Faux. Le centre biologique ne définit pas les conditions collectives. E : Vrai. Ce sont des dispositifs et règles collectifs.

Corrigés argumentés

Les déterminants commerciaux

Q21 — Réponses : A, B, D. Les effets directs ou indirects sur la santé d'activités poursuivant un objectif commercial. Ils passent notamment par la production, les prix, la promotion et l'influence. A : Vrai. Le lobbying peut peser sur les règles collectives. B : Vrai. Elle peut modifier leur visibilité et leur attractivité. C : Faux. Les déterminants commerciaux dépassent l'acte d'achat. D : Vrai. L'exposition peut exister même sans consommation volontaire du produit. E : Faux. Le vieillissement biologique n'est pas en lui-même une activité commerciale.

Q22 — Réponses : B, C. Influencer des décisions et des règles dans l'intérêt d'acteurs ou de secteurs. Cette influence peut modifier les conditions collectives de prévention. A : Faux. Il s'agit d'une activité d'influence sociale et politique. B : Vrai. Les règles économiques peuvent influencer l'offre et l'accès. C : Vrai. Ce sont des décisions pouvant affecter la commercialisation. D : Faux. Cette mesure renvoie à l'incidence et à la surveillance. E : Faux. Une influence ne signifie pas un remplacement complet des institutions.

Q23 — Réponses : B, E. Un indicateur alimentaire aide à comparer mais ne décrit pas tout l'aliment et ne supprime ni le coût ni les contraintes matérielles. Une information utile n'équivaut pas à une possibilité d'achat ou de préparation. A : Faux. Les ressources et l'offre restent inégalement réparties. B : Vrai. Un indicateur résume certains aspects de l'aliment. C : Faux. Il ne constitue pas une description exhaustive. D : Faux. L'indicateur ne remplace pas l'analyse de l'offre, des prix et de la promotion. E : Vrai. L'accès ne dépend pas seulement de la compréhension de l'indicateur.

Q24 — Réponses : C, E. Oublier les effets de l'offre, des prix, de la publicité et des conditions de vie. La capacité d'action existe mais s'exerce dans un contexte. A : Faux. Une aide individuelle reste utile, articulée aux autres niveaux. B : Faux. Cette présentation ne constitue pas une preuve d'absence d'effet. C : Vrai. Une responsabilité exclusivement individuelle peut rendre les contraintes invisibles. D : Faux. Critiquer une responsabilité exclusive ne nie pas toute autonomie. E : Vrai. L'environnement peut rendre certains choix plus probables.

Inégalités de santé et gradient social

Q25 — Réponses : B, D. Des écarts de santé entre groupes sociaux, liés à des mécanismes sociaux et institutionnels. L'analyse cherche comment se répartissent les expositions et les ressources. A : Faux. Une moyenne peut progresser alors que des écarts persistent. B : Vrai. Les risques ne sont pas nécessairement répartis de façon égale. C : Faux. Les logiques sociales et institutionnelles sont centrales dans cette notion. D : Vrai. Les possibilités d'action participent aux écarts de santé. E : Faux. Il faut identifier les mécanismes et les groupes sociaux concernés.

Corrigés argumentés

Q26 — Réponses : C. Des écarts peuvent apparaître tout au long des positions sociales. Le gradient ne se limite pas aux deux extrêmes. A : Faux. Le gradient peut concerner toute la distribution sociale. B : Faux. D'autres ressources, expositions et mécanismes interviennent. C : Vrai. C'est le principe d'un gradient. D : Faux. Une tendance collective n'efface pas les différences individuelles. E : Faux. Le gradient décrit une relation sociale, pas une classification clinique unique.

Q27 — Réponses : A, E. Il s'agit de huit années restantes d'écart en moyenne entre les groupes comparés, dans la période étudiée. Ce n'est ni un âge au décès ni une prédiction individuelle. A : Vrai. L'âge de départ doit être distingué de la durée restante. B : Faux. L'espérance de vie est un indicateur moyen. C : Faux. Le diplôme et la profession sont des variables distinctes. D : Faux. La valeur représente une durée restante à partir de 35 ans. E : Vrai. La différence arithmétique est de 48,5 moins 40,5.

Q28 — Réponses : A. Le graphique décrit une association à l'échelle des pays, sans établir une règle de hausse automatiquement proportionnelle. La richesse ne résume pas tous les déterminants. A : Vrai. C'est le niveau de comparaison présenté par ce type de graphique. B : Faux. L'organisation des soins et d'autres déterminants peuvent intervenir. C : Faux. Une proportionnalité arithmétique ne découle pas de l'association. D : Faux. Une association ne suffit pas à démontrer toute la causalité. E : Faux. Un indicateur agrégé ne prédit pas le devenir individuel.

Genre, discriminations et adéquation des soins

Q29 — Réponses : C, D. Le sexe renvoie aux caractéristiques biologiques ; le genre aux rôles, normes et rapports sociaux. Les deux dimensions peuvent participer à des situations de santé différentes. A : Faux. Les normes et rapports sociaux ont leurs propres mécanismes. B : Faux. Ils désignent des dimensions distinctes. C : Vrai. Le modèle le classe parmi les caractéristiques individuelles centrales. D : Vrai. Il décrit une dimension sociale. E : Faux. Une évaluation de la situation et du besoin réel reste nécessaire.

Q30 — Réponses : B, C. Un biais de reconnaissance du besoin et un risque de réponse inadaptée. La représentation sociale ne doit pas remplacer l'évaluation de la situation. A : Faux. Elle illustre justement le risque d'une interprétation prématurée. B : Vrai. L'existence du contact ne suffit pas à établir la qualité de l'évaluation. C : Vrai. Elles peuvent orienter l'écoute et la reconnaissance des besoins. D : Faux. Une représentation de groupe ne remplace pas l'évaluation clinique. E : Faux. Il peut apparaître au sein même du système de soins.

Corrigés argumentés

Q31 — Réponses : A, B. Elle peut altérer la confiance et décourager ou retarder la démarche. L'obstacle ne se réduit donc pas à une mauvaise connaissance de l'offre. A : Vrai. Elle peut agir avant l'utilisation effective des soins. B : Vrai. La relation aux services dépend aussi d'expériences et de représentations. C : Faux. La connaissance ne supprime pas les craintes et les obstacles. D : Faux. La disponibilité ne garantit pas une expérience adaptée. E : Faux. Des mécanismes de méfiance ou de protection peuvent être présents.

Q32 — Réponses : A, C, D. La correspondance entre les besoins réels et la réponse proposée, avec des compétences et une organisation adaptées. Recevoir une personne ne garantit pas à soi seul cette correspondance. A : Vrai. L'adéquation va au-delà de la présence d'une offre. B : Faux. La disponibilité ne suffit pas à décrire la pertinence de la réponse. C : Vrai. L'organisation influence la possibilité de répondre aux besoins. D : Vrai. Une formation insuffisante peut rendre la réponse moins adaptée. E : Faux. Les besoins doivent être appréciés dans leur situation.

Besoin, accès, recours et poursuite des soins

Q33 — Réponses : E. Percevoir le besoin, recourir aux soins, puis utiliser et poursuivre les soins. Un obstacle peut survenir à chacune de ces étapes. A : Faux. Le recours ne garantit ni disparition du besoin ni guérison. B : Faux. Les obstacles peuvent persister après la consultation. C : Faux. Connaître une possibilité ne signifie pas l'utiliser. D : Faux. Ces notions ne forment pas cette succession d'étapes. E : Vrai. Cet enchaînement distingue la perception, la démarche et l'utilisation.

Q34 — Réponses : B, C. L'accès concerne les possibilités d'obtenir des services ; le recours est la démarche effective vers l'offre. Une possibilité théorique peut rester inutilisée. A : Faux. La présence d'une offre ne prouve pas son utilisation. B : Vrai. L'utilisation durable dépend aussi du coût et des contraintes quotidiennes. C : Vrai. La personne peut rencontrer d'autres obstacles à la démarche. D : Faux. Il concerne la démarche effective, à distinguer de sa poursuite. E : Faux. Ils décrivent des dimensions différentes.

Q35 — Réponses : A, B. Un obstacle matériel au recours aux soins. Identifier le besoin ne garantit pas la possibilité d'atteindre l'offre. A : Vrai. Les propriétés de l'offre peuvent aggraver ou réduire la difficulté. B : Vrai. La mobilité conditionne la réalisation de la démarche. C : Faux. Le premier obstacle décrit se situe avant l'utilisation du service. D : Faux. L'obstacle matériel suffit à empêcher la démarche sans refus. E : Faux. Le besoin est déjà reconnu dans la situation décrite.

Corrigés argumentés

Q36 — Réponses : B, D. Le coût, le temps, les contraintes quotidiennes et l'adaptation de la réponse peuvent encore faire obstacle. Le parcours doit être étudié au-delà du premier contact. A : Faux. Le coût et les horaires constituent des contraintes identifiées. B : Vrai. Une réponse adaptée doit pouvoir être mise en pratique. C : Faux. Des difficultés peuvent persister ou apparaître ensuite. D : Vrai. L'obstacle apparaît après la rencontre avec le service. E : Faux. L'offre a déjà été utilisée ; la difficulté décrite est différente.

La littératie en santé

Q37 — Réponses : A, B, D. Accéder à l'information, la comprendre, l'évaluer et l'utiliser. Savoir lire ne suffit pas à garantir ces quatre possibilités. A : Vrai. Donner du sens et apprécier l'intérêt sont deux opérations complémentaires. B : Vrai. La mise en pratique fait partie de la littératie. C : Faux. L'évaluation critique ne se réduit pas à la mémorisation. D : Vrai. Repérer une information ou une ressource constitue une première opération. E : Faux. Le diplôme ne garantit pas l'utilisation des informations dans chaque situation.

Q38 — Réponses : B, D. Non. Elles se complètent : compréhension des soins et possibilités d'agir pour la santé dans la vie quotidienne. L'environnement informationnel et les politiques comptent aussi. A : Faux. L'environnement et l'organisation peuvent faciliter ou compliquer les démarches. B : Vrai. Elle s'intéresse notamment aux échanges et aux soins. C : Faux. Les approches sont complémentaires. D : Vrai. Elle dépasse la seule relation de soin. E : Faux. Les quatre opérations restent pertinentes.

Q39 — Réponses : A, B, D. Un manque d'équipement, une difficulté à utiliser l'outil ou à comprendre les étapes. La difficulté ne traduit pas nécessairement un manque d'intérêt. A : Vrai. Des étapes opaques peuvent limiter l'utilisation effective. B : Vrai. Les compétences numériques participent à l'accès. C : Faux. Une difficulté technique ne prouve pas un désintérêt. D : Vrai. Sans outil accessible, la démarche peut être empêchée. E : Faux. Une procédure exclusivement numérique peut elle-même constituer un obstacle.

Q40 — Réponses : C, E. Employer des mots accessibles, expliciter les étapes et vérifier ce que la personne a compris. Comprendre une information et pouvoir l'appliquer restent deux questions distinctes. A : Faux. La compréhension ne garantit pas les moyens d'agir. B : Faux. Le diplôme ne suffit pas à apprécier la situation réelle. C : Vrai. Un langage accessible peut faciliter la compréhension. D : Faux. Cela risque d'augmenter l'obstacle informationnel. E : Vrai. Cela permet de repérer l'opération qui pose problème.

Corrigés argumentés

Le non-recours : trois formes à distinguer

Q41 — Réponses : C. La situation d'une personne qui ne bénéficie pas d'une offre, d'un droit ou d'un service auquel elle pourrait prétendre. Il n'est pas synonyme de refus volontaire. A : Faux. D'autres mécanismes, comme l'ignorance de l'offre, sont possibles. B : Faux. Une offre peut exister sans être effectivement utilisée. C : Vrai. C'est le décalage central de la notion. D : Faux. Le constat ne suffit pas à expliquer les causes. E : Faux. Cela ne décrit pas le rapport à une offre ou à un droit.

Q42 — Réponses : B. L'ignorance de l'existence d'une offre ou d'un droit. L'obstacle apparaît avant la possibilité de formuler une demande informée. A : Faux. Aucune demande connue et engagée n'est décrite ici. B : Vrai. L'offre est inconnue de la personne. C : Faux. La situation porte sur la connaissance préalable de l'offre. D : Faux. Une ignorance située n'établit pas cette impossibilité générale. E : Faux. Le bénéfice du service n'a pas commencé.

Q43 — Réponses : D, E. Une offre est connue mais aucune demande effective ou complète n'est faite. Les craintes ou la complexité peuvent décourager la démarche. A : Faux. L'absence de demande ne permet pas cette conclusion. B : Faux. La connaissance de l'offre est précisée. C : Faux. Connaissance et demande sont deux étapes distinctes. D : Vrai. La personne connaît l'offre mais n'engage pas la démarche. E : Vrai. Un obstacle relationnel ou social peut décourager la demande.

Q44 — Réponses : A. Une demande a été engagée mais la personne ne reçoit pas effectivement la prestation ou le service. Un délai ou un défaut de coordination peut rompre le parcours. A : Vrai. La demande ne conduit pas au bénéfice effectif décrit. B : Faux. La situation n'établit aucune règle juridique universelle. C : Faux. La réception effective fait précisément défaut. D : Faux. La demande engagée contredit cette conclusion. E : Faux. La démarche a déjà été engagée.

Intervenir : universel ne signifie pas uniforme

Q45 — Réponses : A, C, D. Individuel et familial, communautaire, et systémique. L'action peut soutenir une personne, mobiliser un groupe ou modifier l'organisation. A : Vrai. Les règles et les organisations peuvent être modifiées. B : Faux. Les interventions ne se limitent pas à cette dimension. C : Vrai. Un accompagnement adapté peut viser une personne et ses proches. D : Vrai. Un groupe ou un territoire peut mobiliser des ressources collectives. E : Faux. Les moyens d'action dépassent les contacts individuels de soins.

Corrigés argumentés

Q46 — Réponses : A, B. Une action destinée à tous, avec une intensité adaptée aux besoins et aux obstacles. L'objectif est aussi de réduire le gradient social. A : Vrai. L'action s'adresse à l'ensemble de la population concernée. B : Vrai. Les moyens sont proportionnés aux obstacles rencontrés. C : Faux. La réduction du gradient fait partie de l'objectif. D : Faux. Une action seulement ciblée ne constitue pas à elle seule ce principe universel. E : Faux. Cette uniformité n'est pas le principe de proportionnalité.

Q47 — Réponses : C, D. Les personnes disposent de ressources différentes pour en bénéficier ; sans adaptation, les écarts peuvent persister ou s'accroître. L'égalité formelle de l'offre ne garantit pas l'équité. A : Faux. Elles conduisent à examiner l'adaptation de l'intervention. B : Faux. Une portée universelle peut être conservée avec un soutien proportionné. C : Vrai. La moyenne et la distribution des bénéfices sont distinctes. D : Vrai. Certains obstacles demandent davantage de moyens. E : Faux. Les capacités d'utilisation peuvent différer.

Q48 — Réponses : D. Proposer l'information à tous et ajouter un accompagnement selon les difficultés de langue, de mobilité ou de numérique. L'intensité varie tout en conservant une portée universelle. A : Faux. Il faut aussi considérer les écarts et les besoins persistants. B : Faux. Une catégorie ne suffit pas à déduire les besoins de chaque personne. C : Faux. L'exclusion de publics ne constitue pas une portée universelle. D : Vrai. Les deux composantes du principe sont présentes. E : Faux. La proportionnalité aux besoins est absente.

La roue des interventions et l'exemple HPV

Q49 — Réponses : C, E. Dix-sept fonctions réparties en cinq familles, articulées aux trois niveaux d'intervention. Les fonctions peuvent se combiner dans une même action. A : Faux. Les deux modèles organisent des objets différents : déterminants et interventions. B : Faux. Les cinq familles regroupent des fonctions d'intervention. C : Vrai. Elle dépasse la seule diffusion d'information. D : Faux. La roue n'impose pas cette combinaison systématique. E : Vrai. Les fonctions ne sont pas obligatoirement exclusives.

Q50 — Réponses : C, E. La surveillance suit des indicateurs ; l'orientation met en relation avec des ressources adaptées et veille à la suite. Observer une situation et faciliter une démarche sont des fonctions différentes. A : Faux. La coordination relève notamment de la gestion de cas et de la collaboration. B : Faux. La gestion de cas implique l'organisation d'un accompagnement. C : Vrai. L'action facilite l'accès à une ressource. D : Faux. La consultation de la roue peut désigner un apport d'expertise. E : Vrai. L'action suit l'évolution d'un indicateur.

Corrigés argumentés

Q51 — Réponses : A, C. Les professionnels se rendent auprès des personnes ou des communautés, au lieu d'attendre leur venue. Cela peut réduire certains obstacles au premier contact. A : Vrai. Elle rejoint le public dans son environnement. B : Faux. La mobilisation de partenaires peut faciliter la démarche. C : Vrai. C'est le principe de l'aller-vers. D : Faux. La démarche vise justement à rejoindre les personnes. E : Faux. La poursuite des soins peut encore poser problème.

Q52 — Réponses : A, C. Le plaidoyer cherche à influencer les décisions pour la santé ; le marketing social adapte une communication à un public et à cet objectif. Le marketing social n'est pas une publicité commerciale. A : Vrai. Il poursuit ici un objectif de santé. B : Faux. Le terme est utilisé ici pour une finalité de santé publique. C : Vrai. Il cherche à peser sur les décisions. D : Faux. Le test et l'influence sur les décisions sont des fonctions distinctes. E : Faux. Surveillance, éducation, aller-vers et collaboration peuvent se combiner.

Des stratégies publiques aux différentes couches

Q53 — Réponses : B, D. Pour identifier les déterminants visés et les niveaux par lesquels l'intervention peut agir. Une orientation générale peut se décliner en plusieurs moyens complémentaires. A : Faux. Ces objets doivent être distingués. B : Vrai. L'action peut être individuelle, communautaire ou systémique. C : Faux. Une politique relève de règles et d'organisations collectives. D : Vrai. Les politiques peuvent agir sur les déterminants. E : Faux. Une intention politique ne prouve pas son effet réalisé.

Q54 — Réponses : B, D, E. L'alimentation dépend des pratiques, des réseaux, de l'offre accessible, des conditions économiques et des politiques. Une seule couche ne décrit pas toute la situation alimentaire. A : Faux. Des conditions sociales et matérielles interviennent. B : Vrai. Les conditions matérielles contribuent aux pratiques. C : Faux. L'annonce d'une stratégie ne suffit pas à prouver une transformation effective. D : Vrai. Ils peuvent relier acteurs, offre et communautés. E : Vrai. Les dimensions de santé et de durabilité peuvent se rejoindre.

Q55 — Réponses : B, E. Les spécificités territoriales renvoient notamment à des contextes culturels, sociaux et environnementaux. Le lieu de vie ne doit pas être confondu avec l'hérédité. A : Faux. Le critère d'âge et l'organisation de la politique sont deux niveaux distincts. B : Vrai. Le classement n'impose pas une cause unique. C : Faux. Les liens entre niveaux font partie du raisonnement. D : Faux. Cette assimilation confond contexte et caractéristiques biologiques. E : Vrai. La géographie recouvre des conditions collectives de vie.

Corrigés argumentés

Q56 — Réponses : A, B. Rapprocher des acteurs et des ressources alimentaires pour faciliter des évolutions adaptées à un territoire. Il relie des ressources locales et des conditions collectives. A : Vrai. La démarche territoriale peut mobiliser plusieurs partenaires. B : Vrai. L'offre et les ressources peuvent être examinées ensemble. C : Faux. La démarche agit sur des conditions sociales et matérielles. D : Faux. Ces conditions sont au contraire pertinentes. E : Faux. Un projet collectif ne permet pas cette prédiction individuelle.

Mobiliser le raisonnement infirmier

Q57 — Réponses : B, D, E. Explorer les contraintes, la compréhension, les ressources et les possibilités d'accompagnement avec la personne. Le problème clinique reste évalué, tout en étant relié aux conditions de vie. A : Faux. Les contraintes décrites peuvent empêcher la réalisation. B : Vrai. Un obstacle informationnel peut se cumuler aux contraintes matérielles. C : Faux. L'analyse des déterminants complète l'évaluation clinique. D : Vrai. L'aide doit être réalisable dans le quotidien. E : Vrai. L'entourage et les services peuvent soutenir la démarche.

Q58 — Réponses : B, C. Pour comprendre la difficulté réelle avant d'en déduire une cause ou une intention. Une description factuelle oriente des questions utiles et une aide adaptée. A : Faux. Une catégorie ne décrit pas toute la situation individuelle. B : Vrai. Un constat ne suffit pas à prouver une motivation. C : Vrai. Elles éclairent la situation et les possibilités d'aide. D : Faux. Des obstacles matériels, sociaux ou organisationnels peuvent intervenir. E : Faux. Décrire sans juger permet justement de mieux les identifier.

Q59 — Réponses : A, E. Vérifier la compréhension, la possibilité de faire la démarche et la persistance éventuelle d'autres obstacles. Une mesure proposée n'est pas encore un bénéfice effectif. A : Vrai. Une proposition peut rester inaccessible ou impraticable. B : Faux. La remise d'information ne prouve pas sa compréhension ni son utilisation. C : Faux. Une quantité de conseils ne mesure pas leur utilité réelle. D : Faux. Une réévaluation permet de vérifier les effets de la réponse. E : Vrai. Les difficultés peuvent se déplacer ou se cumuler.

Q60 — Réponses : A, E. Une tendance collective ne décrit pas toute la situation, les ressources ou les choix d'une personne. L'écoute et l'évaluation individuelle restent indispensables. A : Vrai. Ils aident à explorer des mécanismes possibles. B : Faux. Les situations individuelles peuvent différer. C : Faux. Les deux lectures peuvent se compléter. D : Faux. La précarité ne rend pas les expériences identiques. E : Vrai. Les appartenances collectives ne suffisent pas à la connaître.